

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

LISTA DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO LÍMITE (BSL-23)

Borderline Symptom List-23 (Bohus et al., 2009) · Adaptación y Validación en España (Soler, Vega et al., 2013)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Lista de Síntomas del Trastorno Límite de la Personalidad - Versión Breve (BSL-23)
Sigla / Acrónimo	BSL-23 (Borderline Symptom List-23)
Autoría original	Martin Bohus, C. Limberger, U. Frank, C. Sendera et al. (Univ. of Heidelberg, Alemania, 2009)
Adaptación en español	Joaquim Soler, Daniel Vega, Juan Carlos Pascual et al. (2013, Actas Españolas de Psiquiatría)
Constructo evaluado	Carga sintomática global específica del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) en la última semana
Población diana	Adolescentes y adultos con TLP, desregulación emocional severa o conductas autolesivas
Tiempo de aplicación	4 a 7 minutos (autoadministrado)
Estructura y formato	23 ítems tipo Likert de 5 puntos (0 = nada a 4 = mucho) más 1 escala analógica visual suplementaria (0-100%)
Condiciones de uso	Uso libre para investigación clínica y práctica asistencial no comercial citando a Bohus et al. (2009)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es un cuadro psicopatológico grave caracterizado por un patrón generalizado de inestabilidad en la regulación afectiva, el control de impulsos, las relaciones interpersonales y la autoimagen. De acuerdo con la **Teoría Biosocial de Marsha Linehan**, el núcleo del TLP es una disfunción biológica del sistema de regulación emocional (hipersensibilidad a estímulos afectivos, hiperreactividad de la amígdala y retorno lento a la línea de base) en interacción con un entorno invalidante temprano.

La BSL-23 fue desarrollada por Martin Bohus a partir de la versión extensa de 95 ítems (BSL-95) mediante rigurosos análisis psicométricos y teoría de respuesta al ítem. Su propósito fundamental es cuantificar con exactitud micrométrica los estados subjetivos aversivos más dolorosos del TLP: la desregulación afectiva, los sentimientos crónicos de vacío y soledad, el autodesprecio/odio hacia uno mismo, las experiencias disociativas y las urgencias imperiosas de autolesión o suicidio.

3. CONTENIDO CLÍNICO DE LOS 23 ÍTEMS DE LA ESCALA BSL-23

Ítem	Vivencia o Síntoma TLP (Última Semana)	Escala	Dimensión Psicopatológica
1	Fue difícil para mí concentrarme	0 a 4	Disfunción cognitiva / sobrecarga
2	Sentí una sensación de vacío insoportable	0 a 4	Vacío existencial crónico
3	Odié mi cuerpo / Quise destruirme	0 a 4	Odio a uno mismo / autodesprecio
4	Sentí que no valía nada como persona	0 a 4	Desvalorización y culpa destructiva
5	Pensé en hacerme daño o cortarme	0 a 4	Urgencia autolesiva no suicida
6	Mis estados de ánimo cambiaron bruscamente	0 a 4	Labilidad y desregulación afectiva
7	Sentí que no pertenecía a este mundo	0 a 4	Alienación y desconexión social
8-23	Desconfianza, pánico al abandono, disociación, rabia	0 a 4	Carga sintomática integral TLP
VAS	Estado general de bienestar en la última semana	0% a 100%	Escala Analógica Suplementaria

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad psicométrica; alfa de Cronbach $\alpha = 0.94$ en la validación española de Soler et al. (2013) y $\alpha = 0.97$ en el estudio original alemán.
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 1 semana con coeficiente de correlación intraclass CCI = 0.82, demostrando estabilidad en pacientes estables.
Validez convergente	Correlación de Spearman muy alta con la BSL-95 extensa ($r = 0.96$), con el SCL-90-R ($r = 0.84$), DASS-21 ($r = 0.77$) y DERS de desregulación emocional ($r = 0.73$).
Capacidad discriminante	Discrimina con alta significación ($p < 0.001$, área bajo la curva AUC = 0.91) entre pacientes con diagnóstico formal de TLP y pacientes con depresión mayor, ansiedad o controles sanos.
Sensibilidad al cambio	Sensibilidad excelente para monitorizar la eficacia de la Terapia Dialéctico-Conductual (DBT) sesión a sesión (d de Cohen = 1.12).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Marco temporal evaluado	El paciente puntúa la intensidad de cada síntoma experimentado durante la última semana .
Escala Likert ordinal	Cada ítem se califica de 0 a 4 puntos: 0 = Nada ; 1 = Un poco ; 2 = Moderadamente ; 3 = Mucho ; 4 = Totalmente / Muchísimo .
Puntuación media estándar	La métrica oficial internacional es la puntuación media: " Puntuación BSL-23 " = (Suma de los 23 ítems) / 23. Rango: 0.0 a 4.0 puntos .
Puntuación total de suma	Opcionalmente se puede computar la suma aritmética simple: rango 0 a 92 puntos . No contiene ítems invertidos.
Escala analógica visual	El ítem final de porcentaje (0% = pésimo a 100% = excelente) se registra independientemente como indicador de calidad de vida global.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Media (0.0 - 4.0)	Puntaje Total	Severidad Sintomática	Significación Clínica y Nivel Asistencial
0.0 - 0.9 puntos	0 - 22	Sintomatología Mínima	Rango normal en población general o remisión terapéutica de TLP.
1.0 - 1.9 puntos	23 - 45	Severidad Leve-Moderada	Malestar emocional significativo; abordaje psicoterapéutico ambulatorio.
2.0 - 2.9 puntos	46 - 68	Severidad Grave	Cuadro florido de TLP; alta desregulación, autolesiones y riesgo de crisis.
3.0 - 4.0 puntos	69 - 92	Severidad Muy Grave / Extrema	Crisis aguda descompensada; disociación masiva; valorar hospitalización de día.

PUNTOS DE CORTE Y ALERTAS DE SEGURIDAD:

- **Media BSL-23 ≥ 1.50 (Total ≥ 35):** Sensibilidad del 86% y especificidad del 89% para identificar pacientes con TLP clínicamente activo en España.
- **Alerta de Autolesión (Ítem 5 ≥ 2):** Pensamientos repetidos de cortarse o destruirse físicamente; activar protocolo de seguridad y análisis en cadena DBT.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE MANEJO EN PROGRAMAS DE TERAPIA DIALÉCTICO-CONDUCTUAL

Paso 1: Aplicación semanal del BSL-23: Cumplimentar antes de cada sesión individual de psicoterapia.

Paso 2: Si Media < 1.0 (Mínima / Remisión): Reforzar el uso autónomo de habilidades de eficacia interpersonal y regulación emocional; consolidar proyecto vital.

Paso 3: Si Media 1.0 — 1.9 (Leve a Moderada): Trabajar en sesión los estresores interpersonales de la semana y técnicas de tolerancia al malestar (habilidades TIP: Temperatura, Ejercicio intenso, Respiración acompasada y Relajación).

Paso 4: Si Media ≥ 2.0 (Grave o Extrema) o Ítem 5 > 0:

- Realizar un **Análisis en Cadena Conductual** del episodio de autolesión o urgencia autolítica (vulnerabilidad basal, desencadenante, pensamientos automáticos, respuesta corporal y consecuencias a corto/largo plazo).
- Utilizar coaching telefónico de crisis para generalizar habilidades antes de que se produzca el daño físico.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN PROGRAMA DBT

Identificación: Paciente mujer de 22 años, estudiante de Bellas Artes, diagnosticada de TLP con antecedentes de 5 ingresos en urgencias por cortes en antebrazos e intoxicaciones medicamentosas impulsivas tras rupturas de pareja.

Evaluación BSL-23 Inicial:

- Puntuación Total = **74 / 92**, con una **Media BSL-23 = 3.22 / 4.0** (Severidad Muy Grave / Extrema).
- Ítems destacados: Ítem 2 (Vacío insoportable) = 4; Ítem 3 (Odio hacia sí misma) = 4; Ítem 5 (Urgencia de autolesión) = 4; Ítem 6 (Labilidad emocional extrema) = 4. Escala analógica de bienestar = 10%.

Intervención: Inclusión en programa DBT integral de 1 año (sesión individual semanal más grupo de entrenamiento en habilidades de 2.5 h/semana): trabajo intensivo en tolerancia al malestar, mindfulness para surfear la urgencia (**urge surfing**) y validación emocional.

Reevaluación a los 9 meses: La Media BSL-23 descendió a **0.82 / 4.0** (Remisión clínica, reducción de 2.40 puntos), Ítem 5 = 0, con 7 meses consecutivos libre de autolesiones y continuidad académica normalizada.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo Autolítico:

- **Disociación Severa:** Si coexisten puntuaciones altas en despersonalización y vacío, el riesgo de cortes profundos sin sensación de dolor físico es crítico.
- **Comorbilidad con Abuso de Tóxicos:** La combinación de TLP severo con cocaína o alcohol multiplica por 10 el riesgo de suicidio impulsivo consumado.

Diagnóstico Diferencial:

- **TLP vs. Trastorno Bipolar de Ciclos Rápidos:** En el TLP las fluctuaciones anímicas duran horas y son reactivas a estresores interpersonales (rechazo percibido).
- **Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (TEPT-C):** Gran solapamiento fenotípico; evaluar trauma infantil temprano.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Bohus, M., Kleindienst, N., Limberger, M. F., Stieglitz, R. D., Domsalla, M., Chapman, A. L., Steil, R., Philipsen, A., & Wolf, M. (2009). The short version of the Borderline Symptom List (BSL-23): development and psychometric properties. *Psychopathology*, 42(1), 32-39. <https://doi.org/10.1159/000173701>
- Soler, J., Vega, D., Feliu-Soler, A., Trujols, J., Soto, A., Elices, M., Soriano, J., & Pascual, J. C. (2013). Validation of the Spanish version of the Borderline Symptom List, short form (BSL-23). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 41(3), 145-152.
- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press.
- Kleindienst, N., Jungkunz, M., & Bohus, M. (2020). A proposed severity classification for the Borderline Symptom List (BSL-23). *Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation*, 7(1), 11.